

Памятка пациенту: трициклические антидепрессанты (ТЦА)

Амитриптилин, кломипрамин, имипрамин, нортриптилин, доксепин

О чём эта памятка

Трициклические антидепрессанты (ТЦА) — «первое поколение» АД, по-прежнему эффективны, но с более широким спектром побочных эффектов, чем СИОЗС. К ним относятся: амитриптилин (Elavil), кломипрамин (Anafranil), имипрамин (Tofranil), нортриптилин (Pamelor), доксепин. Часто применяются при тяжёлой депрессии, ОКР (кломипрамин), хронической боли, мигрени, ночном энурезе, нейропатической боли, бессоннице (низкие дозы амитриптилина, доксепина).

Как работают и когда ждать эффекта

ТЦА блокируют обратный захват серотонина и норадреналина, а также взаимодействуют с гистаминовыми (H1), холинергическими (M) и адренергическими ($\alpha 1$) рецепторами. Именно последние взаимодействия объясняют многие побочные эффекты.

Срок	Что происходит
1-7 дней	Побочные эффекты (сухость, сонливость, головокружение) — наиболее выражены.
2-4 недели	Улучшение сна, аппетита. Начинает уменьшаться тревога и боль (если это цель терапии).
4-8 недель	Полный АД-эффект. Для ОКР (кломипрамин) — до 12 недель.

Типичные дозы

Препарат	При депрессии	При боли/сне
Амитриптилин	75–150 мг (макс. 300)	10–50 мг на ночь
Кломипрамин	75–225 мг	—
Имипрамин	75–200 мг	Энурез: 25–75 мг
Нортриптилин	75–150 мг	Боль: 25–75 мг
Доксепин	75–150 мг	Сон: 3–6 мг

Начинают с малых доз, титруют медленно. У пожилых — половинные дозы.

Что МОЖНО и что НЕЛЬЗЯ

✓ Можно

- Принимать вечером (сидируют).
- Использовать в малых дозах при хронической боли и бессоннице.
- Продолжать работу; вождение — только при уверенности в бодрствовании.
- Сочетать с психотерапией.

✗ Нельзя

- ИМАО — перерыв не менее 14 дней.
- Свежий инфаркт миокарда, тяжёлые аритмии, удлинение QT — противопоказаны.
- Закрытоугольная глаукома, задержка мочи, тяжёлая гипертрофия простаты.
- Резко отменять после длительного приёма — синдром отмены (холинергический ребаунд: тошнота, потливость, беспокойство).
- Передозировка ТЦА опасна для жизни — кардиотоксична. Хранить в недоступном для детей месте, у суицидально настроенных пациентов врач может выписывать малыми упаковками.

! С осторожностью

- Алкоголь — резко усиливает седацию, гипотензию, кардиотоксичность. Лучше полностью исключить.
- Антихолинергические препараты (некоторые антигистаминные, спазмолитики) — суммируются побочные эффекты.
- Пожилые — повышенный риск падений, спутанности, ортостатической гипотензии.
- Эпилепсия — ТЦА снижают порог судорог.

Побочные эффекты и как реагировать

Эффект	Что делать
Сухость во рту	Вода, жевательная резинка без сахара, спреи. Обычно уменьшается.
Запор	Клетчатка, вода, при необходимости — лактулоза.
Задержка мочи	Особенно у мужчин с гипертрофией простаты. К врачу.
Ортостатическая гипотензия	Вставать медленно. Осторожность при вставании с постели ночью.
Сонливость	Приём вечером. Утренняя «тяжесть» обычно уменьшается за 1-2 недели.
Прибавка веса	Часто. Контроль питания и активности.
Тахикардия	Если стойкая — ЭКГ. У пожилых — обязательно ЭКГ до начала.
Нечёткость зрения	Обычно проходит. Осторожность за рулём.
Потливость	Транзиторна.
Тремор рук	Обычно мягкий, при выраженном — обсудить с врачом.

⚠ Когда СРОЧНО связаться с врачом или вызвать скорую (103 / 112)

- Мысли о самоповреждении или суициде, особенно с планом.
- Резкое возбуждение, ажитация, спутанность сознания.
- Высокая температура + мышечная ригидность + потливость + дрожь + тахикардия (подозрение на серотониновый синдром).
- Сильная сыпь, отёк лица/губ, затруднённое дыхание (аллергия).
- Кровотечения: длительное носовое, кровь в стуле, обильные синяки.
- Судороги, обморок, необычно медленный или частый пульс.
- Резкое усиление тревоги/панические атаки в первые 1–2 недели (может потребоваться коррекция дозы или временное «прикрытие»).

Вождение автомобиля

ТЦА — единственная группа АД с доказанным ухудшением driving performance, эквивалентным алкоголю 0,5–0,8 ‰ (van der Sluiszen 2021). Особенно в первые 1–2 недели и при повышении дозы.

- В первые 1–2 недели — не садиться за руль.
- При хроническом стабильном приёме — вождение возможно, но с осторожностью.
- Утром после вечернего приёма амитриптилина возможна остаточная сонливость — оценить состояние перед поездкой.
- Алкоголь + ТЦА + руль — категорически нельзя.

Беременность и планирование

! Позиция руководств

ТЦА не являются препаратами первого выбора в беременности (предпочтителен сертралин). Однако:

- Нортриптилин, амитриптилин — при необходимости используются; крупные когорты не показывают значительного увеличения тератогенности.
- Кломипрамин — данных меньше; связан с более выраженным неонатальным синдромом адаптации.
- В III триместре возможен транзиторный неонатальный антихолинергический синдром (тахикардия, задержка мочи у новорождённого).

Источники: MotherToBaby, ACOG, Eleftheriou 2023.

Грудное вскармливание

✓ Совместимость

- Нортриптилин и имипрамин — препараты выбора среди ТЦА при лактации (низкие уровни в молоке, LactMed).
- Амитриптилин — совместим, уровни низкие.
- Доксепин — не рекомендован при кормлении (описаны случаи сонливости и угнетения дыхания у младенцев).
- Кломипрамин — данных мало, обычно допустим.

Источники: LactMed, UK SPS.

Отмена

- Синдром отмены ТЦА связан преимущественно с холинергическим ребаундом: тошнота, диарея, потливость, беспокойство, инсомния, иногда гриппоподобное состояние.
- Снижение дозы — на 25% каждые 2–4 недели.
- При приёме > 1 года — снижать ещё медленнее.
- Никогда не отменять резко.

Развенчание мифов

Развенчание мифов

Миф: «ТЦА устарели, их не должны назначать»

На самом деле: Устарели как препараты «первой линии» из-за побочных, но остаются очень эффективными, особенно при тяжёлой депрессии и сопутствующей боли/бессоннице.

Миф: «Амитриптилин от бессонницы вреднее, чем «Z-препараты»»

На самом деле: В малых дозах (10–25 мг) обычно хорошо переносится и не даёт зависимости, в отличие от зопиклона/золпидема.

Миф: «Они «сажают сердце»»

На самом деле: В терапевтических дозах у здорового сердца безопасны. Опасность — при передозировке или у людей с уже нарушенным проведением. Поэтому у пожилых и с ССЗ делают ЭКГ до начала.

Миф: «Из-за побочных они не работают на настроение»

На самом деле: Работают, и часто мощно. Побочные обычно уменьшаются через 2 недели.

Частые вопросы

Частые вопросы (FAQ)

Мне назначили амитриптилин 25 мг «от боли» — это антидепрессант?

Да, это молекула АД, но в такой дозе — обезболивающий/снотворный эффект.

Антидепрессивные дозы намного выше (75+ мг).

Почему так сильно сушит во рту?

Антихолинергический эффект. Обычно уменьшается за 2 недели. Помогают вода, жевательная резинка без сахара, спреи для полости рта.

Можно ли пить, если утром жутко хочется спать?

Обсудите с врачом — возможно, стоит перенести приём на более ранний вечер или снизить дозу. НЕ бросайте препарат сами.

Что делать при передозировке?

Немедленно вызвать скорую (103 / 112). Передозировка ТЦА жизнеугрожающая. Хранить препарат в недоступном для детей месте.

Кломипрамин при ОКР — это надолго?

При ОКР курс лечения обычно дольше, чем при депрессии — 1–2 года и более после ремиссии, чтобы предотвратить возврат навязчивостей.

Питание и образ жизни

Антидепрессант работает лучше, если помогать ему извне. Ниже — то, что имеет доказательную базу (не БАДы, не «волшебные» диеты).

Питание

- Средиземноморский тип питания (овощи, рыба, оливковое масло, бобовые, цельные злаки, орехи) — единственный тип питания с доказанным умеренным антидепрессивным эффектом (SMILES trial, 2017; PREDIMED).
- Омега-3 (жирная рыба 2 раза в неделю) — вспомогательный эффект при депрессии, особенно EPA-обогащённые формы.
- Регулярность приёмов пищи: пропуск еды усиливает тошноту и головокружение от многих АД.
- Достаточно воды (1,5–2 л/сут) — уменьшает сухость во рту и запоры.

Кофеин и энергетики

- До 200–300 мг кофеина в сутки (2–3 чашки кофе) — обычно безопасно.
- При выраженной тревоге и бессоннице лучше отказаться от кофе после 14:00.
- Энергетики и предтренировочные комплексы нежелательны — содержат высокие дозы кофеина и стимуляторов, усиливают тревогу и сердцебиение.

Сон

- Ложиться и вставать в одно и то же время (± 30 мин), даже в выходные.
- Экран за 30–60 минут до сна — выключить. Синий свет подавляет мелатонин.
- Если препарат бодрит (флуоксетин, венлафаксин, бупропион) — принимать утром. Если седирует (миртазапин, тразодон, амитриптилин, пароксетин) — вечером.

Физическая активность

- 150 минут аэробной нагрузки в неделю (быстрая ходьба, плавание, велосипед) — эффект сопоставим с лёгкими формами депрессии на монотерапии (Cochrane, 2013; meta-analyses 2023).
- Силовые тренировки 2 раза в неделю — дополнительный эффект на тревогу и самооценку.
- Начинать с малого: 10 минут в день — уже работает.

Дисклеймер. Этот документ — информационная памятка, а не медицинская инструкция. Все решения о начале, изменении дозы и отмене препарата принимаются только совместно с лечащим врачом. Материал подготовлен на основе современных источников: NICE NG222 (2022–2024), APA Practice Guidelines, WFSBP, Maudsley Prescribing Guidelines (14-е изд.), NIH LactMed, MotherToBaby, Cochrane Reviews.